

ΔΗΓΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΖΩΟΥ ΝΟΣΟΣ ΑΜΥΧΩΝ ΓΑΛΗΣ

Δήγματα από άνθρωπο: Οι βλάβες εντοπίζονται συχνότερα στα άνω άκρα, με δεύτερη συχνότερη εντόπιση την περιοχή του προσώπου και του τραχήλου. Παρότι συχνά έχουν αθώα εμφάνιση, διότι είναι μικρά τραύματα, χωρίς ιδιαίτερη αιμορραγία, υποκρύπτουν συνήθως βλάβες στους υποκείμενους ιστούς. Προκαλούν σύνθλιψη ή/και θλάση των ιστών. Έτσι, οι τραυματισμένοι τένοντες (*ειδικώς των άνω άκρων*), με το τοπικό οίδημα και την αντιδραστική συστολή τους, δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού της άρθρωσης από το περιβάλλον και ως εκ τούτου εξάπλωση της λοίμωξης, με αποτέλεσμα σοβαρές επιπλοκές, όπως κυτταρίτιδα, λεμφαγγειίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, απόστημα.

Οι λοιμώξεις αυτές είναι πολυμικροβιακές και οφείλονται τόσο σε αερόβια όσο και σε αναερόβια μικρόβια. Τα συχνότερα παθογόνα είναι: *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp και ειδικά είδη, όπως η *Eikenella corrodens*, *Prevotella*, *Actinomyces* και *Bacteroides*.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο πόνο στη δηχθείσα άκρα χείρα, δυσκαμψία και περιορισμό κίνησης ή σύγκλεισης των πασχόντων δακτύλων. Αν ο ασθενής καθυστερήσει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, τότε είναι πιθανό να εμφανιστούν σημεία λοίμωξης μετά από 1-3 ημέρες, όπως οίδημα, ερυθρότητα, τοπική θερμότητα, εκροή πύου και πυρετός.

Δήγματα σκύλου: Αποτελούν το 80-90% όλων των αναφερόμενων δηγμάτων από ζώα. Λοίμωξη παρατηρείται στο 5% των περιπτώσεων, κυρίως σε άτομα ηλικίας > 50 ετών, με βαθιά τραύματα της άκρας χειρός και κυρίως όταν η θεραπευτική αντιμετώπιση καθυστερεί πέραν των 24 ωρών ή σε ασθενείς με ασπληνία, ιστορικό αλκοολισμού, ανοσοκαταστολή ή καρκίνο. Προκαλούν πολυμικροβιακές λοιμώξεις, οφειλόμενες σε αερόβια και αναερόβια. Τα συχνότερα παθογόνα μικρόβια, είναι: *Carnocytophaga canimorsus* [*gram* (-) *βάκιλλος*], *Pasteurella multocida* [*gram* (-) *κοκκοβάκιλλος*], *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp, *Actinomyces* sp. [*προαιρετικά αναερόβια gram* (+) *βακτήρια*], *Prevotella* και *Bacteroides* sp.

Δήγματα γάτας: Αφορούν στο 5-20% του συνόλου των δηγμάτων. Επιμολύνονται σε ποσοστό που κυμαίνεται σε 50-80%. Κυριότερο παθογόνο είναι η *Pasteurella multocida* που προκαλεί ταχύτατα (*περίπου 24 ώρες μετά τον τραυματισμό*) φλεγμονή με πόνο και οίδημα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει τενοντοθυλακίτιδα, οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα (*σε δήγμα στα δάκτυλα*), ρήξη τενόντων, απόστημα και βακτηριαιμία σε ανοσοκατεσταλμένους.

Νόσος εξ αμυχών γαλής: Οφείλεται σε *gram* (-) αρνητικό, πλειόμορφο, βακτηρίδιο. Ως υπεύθυνος παράγων έχει απομονωθεί η *Bartonella henselae*. Η νόσος εξ αμυχών γαλής (*cat scratch disease - CSD*) προσβάλλει κυρίως νέους ή παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στα παιδιά μάλιστα αποτελεί σχεδόν το 1/3 των περιστατικών πυρετού αγνώστου αιτιολογίας. Έχει παρατηρηθεί συχνότερα σε γυναίκες, κυρίως τον χειμώνα και την άνοιξη. Το μικρόβιο μεταδίδεται στον άνθρωπο από τις γάτες, συνήθως με το γρατζούνισμα ή το δάγκωμα, αφού βρίσκεται στα νύχια και τα δόντια τους, ή σπανιότερα με ψύλλους. Συνηθέστερα, φέρουν το μικρόβιο τα μικρά γατάκια και οι γάτες των δρόμων (*ξενιστές*), που το μεταδίδουν στους ανθρώπους μετά από τραυματισμό. Σπανίως, έχει παρατηρηθεί μετάδοση και από σκύλους.

Χαρακτηρίζεται γενικά από επώδυνη, σύστοιχη με την πρωταρχική δερματική βλάβη λεμφαδενοπάθεια (που μπορεί να διαρκέσει 1-4 μήνες), αδιαθεσία, κακουχία, εξάντληση, πυρετό που μπορεί να φτάσει έως 39-39,5 °C, ανορεξία, κεφαλαλγία, εξάνθημα. Στο σημείο της δερματικής βλάβης παρατηρείται βλατίδα η οποία αργότερα μετατρέπεται σε εφελκίδα.

Συνήθως, μετά από λίγους μήνες, η ασθένεια υφίσταται μόνη της χωρίς προβλήματα. Παρ' όλα ταύτα, περιγράφεται ένα ποσοστό 15-20% ασθενών, που πιθανώς να εμφανίσουν εκδηλώσεις από άλλα όργανα ή ιστούς, όπως επιπεφυκίτιδα, ραγοειδίτιδα, σπληνομεγαλία, θρομβοπενική πορφύρα, οστεομυελίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, περιφερική νευρίτιδα, κ.ά.

Η διαφορική διάγνωση της νόσου, περιλαμβάνει: τη βρουκέλλωση, την τουλαραιμία, τη φυματίωση, την πρωτοπαθή σύφιλη, την τοξοπλάσμωση, τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, την λοίμωξη από CMV ή HIV, τη νοκαρδίαση, τα νεοπλάσματα (*λέμφωμα Hodgkin*), κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Το πρώτο μας βήμα είναι η εκτίμηση του τραύματος με τον έλεγχο του βαθμού και της έκτασης της βλάβης των ιστών. Επίσης, η εξακρίβωση του είδους του ζώου και αν είχε προηγηθεί πρόκληση του ζώου ή επιτέθηκε απρόκλητα. Αν υπάρχει πιθανότητα λύσσας το ζώο θα πρέπει να βρεθεί και να παρακολουθηθεί για 10 ημέρες από κτηνίατρο.
2. **Ουδέποτε ράβουμε το τραύμα!** Σε εκτεταμένα τραύματα ή σε τραύματα με απόσπαση δερματικού κρημνού, ίσως χρειαστεί να τοποθετήσουμε 1-3 συμπλησιαστικά ράμματα. Σε δήγματα - τραύματα τα οποία εντοπίζονται στο πρόσωπο, η σύγκλιση επιχειρείται με ειδικές ταινίες steril-strip και ο ασθενής παραπέμπεται σε πλαστικό χειρουργό, άμεσα.
3. Εκτελείται, προσεκτικά, ευρύς και επιμελής μηχανικός και χειρουργικός καθαρισμός. Αφαιρούμε με λαβίδα και νυστέρι τους νεκρωμένους ιστούς και τα ιστικά ράκη. Σημαντικό είναι, να διηθήσουμε το τραύμα με φυσιολογικό ορό, για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μικροβιακής λοίμωξης και λύσσας η οποία δυστυχώς επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα (Μακεδονία, ΒΔ Θεσσαλία και Πίνδο) από το 2012 (βλ. παρακάτω, ορός/εμβόλιο). Πλένουμε το τραύμα με άφθονο φυσιολογικό ορό, για 3-5 λεπτά, με τη χρήση σύριγγας 20 ή 60 ml, κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται ροή υψηλής πίεσης προς στο τραύμα.
4. Σε βαθύ, ρυπαρό και νεκρωμένο τραύμα, συχνά εμποτίζουμε ύπερθεν ή εντός αυτού, εκτός από οξυζενέ (H₂O₂) και Betadine και με 1-3 amp. Amikacin 250 mg ή 500 mg. Κατόπιν, μετά από παρέλευση 3-5 λεπτών, ξεπλένουμε με άφθονο φυσιολογικό ορό.
5. Ανοσοποίηση, με αντιτετανικό ορό (HTIG: inj. sol. Tetagam-P, 250 IU) (im), εφάπαξ. Αν ο ασθενής προσέλθει στο ιατρείο μετά την παρέλευση 24 ωρών ή το δήγμα είναι βαθύ κι εκτεταμένο ή αν έχει υψηλό BMI, τότε διενεργούμε διπλάσια δόση του ορού HTIG.
6. Αντιμικροβιακή κάλυψη με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, βάσει ενδείξεων, όπως:
 - ♦ Amoxi/Clav (*Augmentin*) 1 gr, 1x2 ή 1x3 (po), για 7-10 ημέρες, ή
 - ♦ Doxycycline (*Vibramycin*) 100 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες, ή
 - ♦ Ciprofloxacin (*Ciproxin*) 500 mg, 1x2 (po), για 5-7 ημέρες.
 - Επίσης, κάλυψη και για αναερόβια (Dalacin-C 300 mg, 1x3 ή Flagyl 500 mg, 1x3).(Όπως ειπώθηκε, συχνότερα παθογόνα, είναι: *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, Gram (+) αναερόβιοι κόκκοι, *Fusobacterium spp.*, και διάφορα άλλα Gram (-) αναερόβια βακτήρια, τα οποία και στοχεύουμε κατά το πλείστον με την αγωγή).
7. Εκτελούμε συχνές και επιμελείς αλλαγές στο τραύμα (1^η, 2^η, 3^η, 5^η, 7^η, 10^η, 15^η ημέρα). Επαγρυπνούμε, πάντοτε, για πιθανή δημιουργία φλεγμονής ή ιστικής νεκρώσεως.
8. Ασθενείς με σοβαρό τραυματισμό, υπό ανοσοκαταστολή, με σοβαρές συννοσηρότητες ή επί εμφανίσεως φλεγμονώδους διεργασίας στην περιοχή του δήγματος, παραπέμπονται στο νοσοκομείο για χειρουργική εκτίμηση και περαιτέρω αντιμετώπιση ή νοσηλεία.
9. Αντιλυσσικός εμβολιασμός και έγκαιρη χορήγηση ειδικής ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης εφόσον υπάρχει υποψία για δήγμα από ύποπτο ζώο (βλέπε ΑΔΑ: 67Ν9Θ-ΧΟ1, 23/1/2015). Η ειδική ανοσοσφαιρίνη κατά του ιού της λύσσας (αντιλυσσικός ορός) που κυκλοφορεί στην Ελλάδα (*Berirab-P*, inj. 750 IU / amp των 5 ml), διατίθεται μέσω του ΙΦΕΤ προς όλες τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, τα Νοσοκομεία ή τα ΚΥ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, μετά από δήγμα υπόπτου ζώου (π.χ. σκύλος, αλεπού, πίθηκος, κ.ά.). Η συνιστώμενη δοσολογία της ανοσοσφαιρίνης, είναι 20 IU/kg ΒΣ, η οποία αντιστοιχεί συνήθως σε 2 αμπούλες ανοσοσφαιρίνης *Berirab-P*, για έναν ενήλικα με ΒΣ ≈ 70-90 kg. Ο εμβολιασμός για τη λύσσα πραγματοποιείται σε άλλο ανατομικό σημείο από εκείνο της ανοσοσφαιρίνης και εκτελείται σε πέντε (5) δόσεις, κατά τις ημέρες 0, 3, 7, 14, 28.
10. Στην περίπτωση της νόσου εξ αμυχών γαλής (CSD), χορηγούμε απλά αντιπυρετικά ή/και παυσίπονα, επί αναλόγων συμπτωμάτων. Σε περιπτώσεις με συστηματικές εκδηλώσεις της νόσου, χορηγούμε την ενδεικνυόμενη αντιβιοτική θεραπεία, ήτοι:
 - tbs. Azithromycin (*Zinfect*) 600 mg, 1x1 (po), για 5 ημέρες, ή
 - tbs. Ciprofloxacin (*Ciproxin*) 500 mg, 1x2 (po), για 10-14 ημέρες, ή
 - tbs. Rifampicin (*Rifadin*) 600 mg, 1x1 (po), για 14 ημέρες.

